

ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA EN URGENCIAS.

Francisco Javier González Espinel, Laura Maria Blanco Álvarez, Laura Gómez del Campo.

El sistema de Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO) es un sistema básico de la Red de Vigilancia Epidemiológica, orientado a la detección y control precoz de enfermedades transmisibles que por su potencial epidémico puedan suponer un riesgo para la salud de la población.

Todos los médicos en ejercicio, en caso de sospecha clínica, deben realizar la notificación de las EDO de acuerdo con el listado del RD 2210/1995 y su posterior ampliación con la Orden SSI/445/2015.

Existen 3 modalidades de notificación en función de la enfermedad y cada comunidad autónoma posee sus propios formularios.

3 MODALIDADES DE NOTIFICACIÓN

Declaración numérica semanal:

A. Declaración con datos epidemiológicos básicos agrupados cada 4 semanas.

B. Declaración urgente con datos epidemiológicos básicos. Notificar en las primeras 24h desde el diagnóstico de sospecha:

- En horario laboral: Sección de Epidemiología del Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social.
- En Tardes, noches, sábados y festivos: Sistema de Alertas Epidemiológicas (112)

C. Declaración semanal con datos epidemiológicos básicos.

D. Informe anual con datos epidemiológicos básicos.

Declaración de enfermedades incluidas en sistemas especiales.

Enfermedades endémicas de ámbito regional.

Listado EDO 2019 Por Orden Alfabético. Tipo De Notificación Y Claves Para Su Manejo.

Botulismo

Declaración C.

Se considerará prioritario el traslado del enfermo a una unidad hospitalaria de cuidados intensivos y la administración precoz de antitoxina botulínica. La sospecha de un solo caso de botulismo debería plantear la investigación de un posible brote en cualquier ámbito y la investigación de los alimentos compartidos.

Brucelosis

Declaración C.

Es una enfermedad de carácter ocupacional que afecta a personas que trabajan con animales o en laboratorio. En España es una enfermedad en vías de control y sujeta a programas de erradicación en animales. La transmisión persona a persona es muy rara.

Campilobacteriosis

Declaración A.

De manera general, se procederá a la rehidratación y reposición de electrolitos. El tratamiento con antimicrobianos sólo tiene valor si se usa en las fases tempranas de la infección, en los casos graves y para la eliminación del estado de portador. Usar precauciones de contacto para niños menores de 6 años con pañales o incontinentes durante la duración de la enfermedad.

Carbunco

Declaración C.

El hombre adquiere la infección por contacto, ingestión o inhalación de esporas, normalmente procedentes de animales infectados o sus productos. En más del 95% de los casos la infección es cutánea.

Cólera

Declaración B.

El tratamiento del cólera se basa en la rápida rehidratación del paciente. Usar precauciones de contacto para niños menores de 6 años con pañales o incontinentes durante la duración de la enfermedad.

Criptosporidiosis

Declaración A.

La rehidratación es el principio básico del tratamiento. Usar precauciones de contacto para niños menores de 6 años con pañales o incontinentes durante la duración de la enfermedad.

Dengue

Declaración C.

En España todos los casos notificados hasta la fecha han sido importados. No existe tratamiento específico ni profilaxis. Está contraindicado el uso de ácido acetilsalicílico.

Difteria

Declaración B.

El paciente permanecerá en aislamiento por gotas si padece difteria respiratoria y en aislamiento de contacto en la difteria cutánea. Además, todos los objetos que hayan estado en contacto directo con el paciente o con sus secreciones deberán desinfectarse.

Encefalopatías Espongiformes Transmisibles Humanas (EETH)

Declaración A.

Utilizar, siempre que sea posible, instrumentos desechables y poner en marcha los protocolos más estrictos de lavado y desinfección.

Encefalitis Transmitida Por Garrapatas

Declaración C.

Revisar las superficies del cuerpo expuestas para comprobar si se ha adherido alguna garrapata. Se deberá eliminar de forma cuidadosa, valiéndose de tracción suave y constante con pinzas y enviarla a analizar al laboratorio de Salud Pública.

Enfermedad Invasora Por Haemophilus Influenzae Tipo B

Declaración A.

Todo caso de cualquier edad deberá estar en aislamiento por gotas hasta 24 horas después de iniciar el tratamiento.

Enfermedad Meningocócica

Declaración C.

Las medidas preventivas son la vacunación, la administración de quimioprofilaxis a los contactos próximos de los casos y medidas de precaución por gotas hasta 24 horas después de iniciar el tratamiento. Se recomienda la administración de quimioprofilaxis lo antes posible tras el diagnóstico del caso, en las primeras 24 horas, siendo dudosa su utilidad después de 10 días.

Enfermedad Neumocócica Invasora

Declaración A.

El tratamiento con un antibiótico, al que sea sensible, interrumpe la transmisibilidad después de 24 horas de iniciar su uso.

A los pacientes que tengan factores de riesgo y que no estén vacunados se les ofrecerá la vacuna.

Enfermedad Por Virus Chikungunya

Declaración C

No existe tratamiento específico ni profilaxis. Dado que no se transmite persona-persona, se tomarán las precauciones estándar en el medio sanitario.

Fiebre Amarilla

Declaración B.

No existe un tratamiento específico por lo que se administrará tratamiento de soporte y sintomático. Precauciones estándar.

Fiebre Exantemática Mediterránea

Declaración C.

La fiebre exantemática mediterránea, también llamada fiebre botonosa, es la rickettsiosis más frecuente en Europa. Se trata de una enfermedad endémica en algunas zonas de España y emergente en otras. Su control se basa en la detección precoz, el tratamiento de los casos y el control de los reservorios y vectores.

Fiebres Hemorrágicas Víricas (Ébola, Marburg Y Lassa Entre Otras)

Declaración C.

Las precauciones adecuadas para el manejo de los pacientes probables/confirmados de FHV incluyen precauciones de contacto y de transmisión aérea.

Asegurar que todas las personas que van a estar en contacto con el paciente, o con sus fluidos o excreciones, utilicen equipo de protección individual (EPI).

Fiebre Recurrente Por Garrapatas

Declaración C.

Para la extracción de la garrapata del lugar de la mordedura se protegerán las manos con guantes y mediante unas pinzas se tomará la garrapata cerca de la cabeza, con un movimiento lento y firme se tirará hacia afuera con cuidado para no aplastarla ni partirla.

A continuación, se debe lavar la zona de la mordedura y las manos.

Fiebre Q

Declaración C.

Afecta principalmente a grupos con exposición ocupacional. La población rural es la más afectada. Actualmente en Europa no hay vacuna autorizada para prevenir la enfermedad en la población

Fiebre Tifoidea Y Paratifoidea

Declaración C.

La vacunación rutinaria para la fiebre tifoidea no está recomendada en áreas no endémicas excepto en contactos de riesgo (convivientes y contactos íntimos de portadores crónicos conocidos de fiebre tifoidea) y personal de laboratorio. Además, la OMS recomienda la vacunación de viajeros internacionales a zonas endémicas.

Giardiasis

Declaración A.

Usar precauciones de contacto para niños menores de 6 años con pañales o incontinentes durante la duración de la enfermedad

Gripe

Declaración C.

El tratamiento antiviral se recomienda, tan pronto como sea posible, en pacientes con sospecha de gripe o gripe confirmada que sea hospitalizado o si la enfermedad progresa con complicaciones.

La vacunación es la medida de elección para prevenir la gripe estacional y una de las intervenciones más importantes en el caso de una pandemia.

Gripe Humana Por Un Nuevo Subtipo De Virus

Declaración B.

Hepatitis A

Declaración C.

En el caso de paciente incontinente precauciones de contacto. En menores de 3 años se mantienen durante toda la hospitalización, entre los 3 y 14 años hasta 2 semanas después del comienzo de los síntomas y en el resto hasta una semana después.

Hepatitis B**Declaración C.**

Se recomienda administrar la profilaxis post-exposición en el plazo más breve posible. La IGHB (inmunoglobulina específica antihepatitis B) se administrará en el periodo de 24 horas siguientes a la exposición y si no ha transcurrido más de 14 días. La IGHB y la vacuna se inyectarán en sitios anatómicos distintos, con distintas jeringas.

Hepatitis C**Declaración A.**

Dado que no existe una vacuna efectiva para prevenir la infección, las actuaciones se centran en disminuir la transmisión de la infección y en la prevención secundaria de cirrosis y carcinoma hepatocelular mediante el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno de los casos de infección crónica.

Herpes Zóster**Declaración D.**

Las personas con herpes zóster pueden transmitir el VVZ por contacto directo con el líquido vesicular de las lesiones cutáneas (y por objetos contaminados). Estas lesiones dejan de ser infecciosas cuando se convierten en costras.

Hidatidosis**Declaración C.**

El control del paciente se basa en el tratamiento específico y la investigación de los miembros de la familia y otros contactos. Es una enfermedad cuyas medidas de control están basadas en actividades y/o programas de control y erradicación en animales.

Infección Gonocócica**Declaración C.**

Los casos deben evitar las relaciones sexuales hasta que ellos y sus parejas hayan completado el tratamiento y estén asintomáticos. No es necesaria ninguna medida de aislamiento.

Infección Por Virus De La Inmunodeficiencia Humana (VIH)**Declaración: Sistemas especiales**

El diagnóstico de la infección por VIH y el consiguiente seguimiento médico ha de hacerse lo antes posible. La administración de PPE, cuando esté indicada, debe iniciarse lo antes posible, mejor en las primeras cuatro horas, y hasta las 72 horas. Pasado este plazo, no se recomienda su inicio. Su duración será de 4 semanas.

Infecciones por Chlamydia Trachomatis (excluye linfogranuloma venéreo)**Declaración A.**

La principal medida en el control de los casos es el diagnóstico y tratamiento precoz, junto con educación sanitaria sobre los síntomas de esta enfermedad y su modo de transmisión. Los casos deben evitar las relaciones sexuales hasta que ellos y sus parejas hayan completado el tratamiento y estén asintomáticos.

Infección por cepas de Escherichia coli productoras de toxina Shiga o Vero**Declaración C.**

Debido a la baja dosis infecciosa, los infectados no deben manipular alimentos ni prestar atención a niños o enfermos hasta la obtención de dos muestras negativas de heces sucesivas o dos frotis sucesivos de material

rectal.

Leishmaniasis

Declaración C.

Se trata de una enfermedad de importancia en salud pública en España al ser endémica en algunas zonas. Su control se basa en la detección precoz, el tratamiento de los casos y el control de los reservorios y vectores.

Legionelosis

Declaración C.

La instauración, lo antes posible, de tratamiento específico a los pacientes es crucial para disminuir la letalidad de la enfermedad. La realización de la encuesta epidemiológica permitirá recoger información relacionada con la exposición del paciente.

Lepra

Declaración C.

No son necesarias medidas de aislamiento de los casos. En España, teniendo en cuenta los bajos niveles de prevalencia e incidencia que se registran anualmente, y que los casos declarados son casi exclusivamente importados, las principales medidas a recomendar son: vigilar el estricto cumplimiento del tratamiento.

Leptospirosis

Declaración C.

La enfermedad se asocia a trabajadores en contacto con animales y/o sus productos y a los relacionados con el medio ambiente en zonas húmedas. Se adoptarán precauciones estándar

Linfogranuloma Venéreo

Declaración A.

La principal medida en el control de los casos es el diagnóstico y tratamiento precoz, junto con educación sanitaria. Los casos deben evitar las relaciones sexuales hasta que ellos y sus parejas hayan completado el tratamiento y estén asintomáticos. No es necesaria ninguna medida de aislamiento.

Listeriosis

Declaración C.

El caso debe recibir tratamiento antimicrobiano, para los contactos sólo es necesaria la vigilancia clínica.

Paludismo

Declaración C.

Es una enfermedad sometida a vigilancia especial por la OMS.

Parotiditis

Declaración C.

Precauciones por gotas, durante nueve días después de la aparición de la inflamación.

El personal sanitario susceptible se debe vacunar.

Peste

Declaración B.

En caso de peste bubónica precauciones estándar y en el caso de peste neumónica precauciones por gotas hasta 72 horas después del inicio del tratamiento.

Poliomielitis/Parálisis Flácida Aguda En Menores De 15 Años

Declaración B.

No existe tratamiento específico para la poliomielitis, pero ésta puede prevenirse mediante la vacunación.

Rabia

Declaración B

En España es posible la aparición de casos humanos esporádicos por mordedura de murciélago o en Ceuta o Melilla por mordedura de perro. Se seguirá el protocolo de actuación ante mordeduras o agresiones de animales (tratamiento post-exposición), basado en las recomendaciones de la OMS.

Rubéola

Declaración C.

Precauciones por gotas hasta 7 días después de la aparición del rash.

Rubéola Congénita

Declaración C.

Precauciones de contacto durante cualquier ingreso del niño hasta la edad de un año, a menos que los cultivos nasofaríngeos y de orina sean negativos para el virus a partir de la edad de tres meses.

Salmonelosis

Declaración A.

Usar precauciones de contacto para niños menores de 6 años con pañales o incontinente durante la duración de la enfermedad.

Sarampión

Declaración C.

El personal sanitario susceptible se debe vacunar^{**}.^{**}

Se adoptará precauciones por transmisión aérea mientras dure la enfermedad.

SARS (Síndrome Respiratoria Agudo Grave)

Declaración B.

Aplicación inmediata de medidas de aislamiento y de protección de barrera del personal asistencial, y de otros posibles contactos, mediante la utilización de los equipos de protección personal (EPI)

Shigelosis

Declaración C.

Usar precauciones de contacto para niños menores de 6 años con pañales o incontinentes durante la duración de la enfermedad.

Sífilis

Declaración C.

La principal medida en el control de los casos es el diagnóstico y tratamiento precoz, junto con educación sanitaria. No es necesaria ninguna medida de aislamiento

Sífilis Congénita

Declaración C.

La importancia de esta enfermedad radica en sus graves consecuencias y en la posibilidad de prevenirla mediante el cribado prenatal y el tratamiento de las embarazadas.

Tétanos /Tétanos Neonatal

Declaración C.

Ante un caso sospechoso de tétanos no se requiere aislamiento ni inmunización de contactos. Se investigará la fuente de infección y las circunstancias en las que se ha producido la herida. En los individuos diagnosticados de tétanos se iniciará o se completará pauta de vacunación frente a tétanos.

Tos Ferina

Declaración C.

Precauciones por gotas hasta 5 días después de iniciar el tratamiento antibiótico.

Toxoplasmosis Congénita

Declaración C.

No hay transmisión persona a persona excepto en el útero.

Triquinosis

Declaración C.

La enfermedad sólo se transmite por ingestión de carne infestada, por lo que no son necesarios métodos de control sobre la persona enferma o el ambiente.

Tuberculosis

Declaración C.

Cuando al servicio de urgencias llega un paciente en el que existe sospecha diagnóstica de tuberculosis, debe ser aislado y permanecer el menor tiempo posible en dicha unidad. El tratamiento correcto de los enfermos es la mejor medida de control. Se debe realizar estudio de contactos en cada caso diagnosticado.

En casos de tuberculosis pulmonar, confirmada o sospecha o enfermedad laríngea se deberán usar precauciones de transmisión aérea hasta que el paciente tenga un tratamiento efectivo, esté mejor clínicamente, y se disponga de tres cultivos consecutivos de esputo negativos recogidos en días diferentes, o se descarte.

Tularemia

Declaración C.

La trascendencia de la tularemia en España, viene dada por su capacidad de producir periódicamente brotes de cierta magnitud, además de su gravedad. Además, del tratamiento específico del paciente, hay que investigar cuidadosamente cada caso para descubrir la fuente de la infección y prevenir nuevos casos.

Varicela

Declaración C.

Precauciones aéreas y de contacto, que se deben mantener hasta que todas las lesiones estén cicatrizadas. La administración de profilaxis en los contactos debe ir dirigida a proteger a los individuos con riesgo de varicela grave.

Viruela

Declaración C.

La viruela es actualmente una enfermedad erradicada.

Yersiniosis

Declaración A.

Usar precauciones de contacto para niños menores de 6 años con pañales o incontinentes durante la duración de la enfermedad.

BIBLIOGRAFÍA

- Real Decreto 2210/1995, del 28 de diciembre, por el que se crea la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. BOE 24 de enero de 1996, núm. 21, pág. 2153 a 2158.
- Orden SSI/445/2015, de 9 de marzo, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre, por el que se crea la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, relativos a la lista de enfermedades de declaración obligatoria, modalidades de declaración y enfermedades endémicas de ámbito regional. BOE de 17 de marzo de 2015, núm. 65, pág. 24012 a 24015.
- Cano Portero R, Sierra Moros MJ, Tello Anchuela O, et al. Protocolos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Madrid: Instituto Nacional de Salud Carlos III. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e

Igualdad; 2015.

- Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Recomendaciones sobre precauciones estándar y precauciones basadas en la transmisión de microorganismos. [Internet]. 2017 [citado 8 enero 2019]. Disponible en:
http://www.resistenciaantibioticos.es/es/system/files/field/files/recomendaciones_sobre_precauciones_estandar.pdf?file=1&type=node&id=364&force=0